Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Septoplastie

Chirurgie de redressement de la paroi centrale du nez (cloison nasale)

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Actes réalisés au cours de la même intervention :
☐ Réduction des cornets (radiofréquence / sous-muqueuse)
☐ Chirurgie endoscopique des sinus — FESS (sur un formulaire de consentement distinct)
☐ Aucun _____

Attelles / mèches nasales :
☐ Attelles en silicone ☐ Mèches ☐ Non nécessaires
☐ À décider pendant l'opération _____

Plainte du patient (côté de l'obstruction, ronflement, maux de tête, etc.) : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

La paroi faite de cartilage et d'os fin qui divise la cavité nasale en côtés droit et gauche s'appelle la **cloison nasale (septum)**. Lorsque la cloison est déviée vers un côté ou vers les deux, on parle de **déviation de la cloison nasale**. Elle peut être présente dès la naissance, apparaître pendant la croissance ou survenir après un coup sur le nez.

Une cloison déviée peut entraîner une obstruction nasale, une respiration par la bouche, des ronflements, un sommeil de mauvaise qualité, une sécheresse de la bouche, des saignements de nez et, chez certaines personnes, des épisodes de sinusite ou des maux de tête. Comme il s'agit d'un problème structurel, il ne s'améliore pas avec des médicaments. Le but de la septoplastie est de redresser les parties déviées afin que vous puissiez **respirer confortablement par le nez**. Cette opération ne vise pas à modifier l'apparence extérieure du nez.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'opération est généralement réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire, entièrement par les narines. Il n'y a ni incision ni cicatrice visible sur le visage.

1. **Incision :** Une petite incision est pratiquée à l'intérieur de la narine, dans la muqueuse qui recouvre la cloison.
2. **Décollement de la muqueuse :** La muqueuse qui recouvre les deux faces de la cloison est délicatement séparée du cartilage et de l'os.
3. **Correction de la déviation :** Les fragments de cartilage et d'os déviés sont retirés, redressés ou repositionnés. Les parties de soutien qui maintiennent la forme extérieure du nez (la charpente cartilagineuse qui soutient le dos et la pointe du nez) sont préservées.
4. **Réduction des cornets (si nécessaire) :** Si les structures de la paroi latérale du nez appelées cornets sont hypertrophiées, elles sont réduites par radiofréquence ou par retrait de tissu sous la muqueuse.
5. **Fermeture :** La muqueuse est remise en place et maintenue par des points résorbables.
6. **Attelles/mèches :** Pour aider la cloison à cicatriser bien droite et pour prévenir les saignements, on place généralement à l'intérieur du nez des attelles souples en silicone munies d'un canal central permettant de respirer, ou des mèches.

Si la partie antérieure et externe de la cloison est également déviée, ou si la forme extérieure du nez contribue à l'obstruction, l'opération peut être associée à une rhinoplastie (septorhinoplastie), à condition que cela soit discuté et fasse l'objet d'un consentement distinct.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale (dans certains cas, anesthésie locale + sédation)	Environ 45–90 minutes	Sortie le jour même ou une nuit d'hospitalisation

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Une respiration nasale plus facile et moins de respiration par la bouche
- Une meilleure qualité de sommeil et moins de ronflements (le ronflement peut aussi avoir d'autres causes)
- Moins de saignements de nez récidivants liés à la déviation et, chez certains patients, moins d'épisodes de sinusite
- Un meilleur accès pour une chirurgie des sinus ou une autre chirurgie nasale si nécessaire

Les publications indiquent qu'environ **70–85 patients sur 100** décrivent une nette amélioration de l'obstruction nasale après l'opération. Si l'obstruction a aussi d'autres causes, comme une allergie, un gonflement de la muqueuse, une faiblesse des ailes du nez ou une maladie des sinus, celles-ci peuvent nécessiter un traitement distinct. Rarement, la cloison peut se dévier à nouveau légèrement avec le temps.

4 Autres options thérapeutiques

- **Ne pas opérer / surveillance :** Si vos symptômes sont légers, une simple surveillance est possible.
- **Traitement médicamenteux :** Les sprays nasaux à base de corticoïdes, les lavages de nez et les médicaments contre l'allergie peuvent soulager les symptômes en réduisant le gonflement de la muqueuse, mais ils ne corrigent pas une déviation structurelle de l'os et du cartilage.
- **Bandelettes nasales / dilatateurs de narines :** Peuvent apporter un soulagement temporaire.
- **Sprays décongestionnants (vasoconstricteurs) :** Ne conviennent que pour quelques jours ; une utilisation prolongée entraîne une dépendance et une obstruction encore plus importante.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si l'opération n'est pas réalisée, la déviation ne se redressera pas d'elle-même ; les symptômes tels que l'obstruction nasale, la respiration par la bouche et les ronflements persisteront et peuvent s'aggraver avec l'âge. Cette situation

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ne met généralement pas la vie en danger ; la décision d'opérer dépend de l'importance de l'impact de vos symptômes sur votre qualité de vie.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Des analyses de sang et, si nécessaire, un scanner des sinus et d'autres examens sont réalisés avant l'opération, et vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste.
- Vous ne devez rien manger ni boire pendant les **6–8 heures** précédant l'opération (veuillez suivre les consignes du médecin anesthésiste).
- Si vous avez un rhume, une grippe ou une maladie avec fièvre dans les jours précédant l'opération, signalez-le-nous ; l'opération peut être reportée.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

48 premières heures	Votre nez sera bouché à cause des attelles, et vous pouvez vous attendre à un léger suintement teinté de sang, à des maux de tête et à une sécheresse de la gorge. La douleur est généralement légère. Il est recommandé de dormir la tête surélevée. La compresse placée sous le nez peut devoir être changée plusieurs fois.
3e–7e jour	Les attelles en silicone ou les mèches sont généralement retirées lors d'une consultation de contrôle **entre le 3e et le 7e jour** ; cela provoque une gêne de courte durée. Les lavages de nez sont alors commencés. La plupart des personnes reprennent un travail de bureau en 5–7 jours.
2e–4e semaine	Des croûtes et une sécheresse à l'intérieur du nez peuvent apparaître et diminuent avec des lavages réguliers. La respiration s'améliore progressivement. Les efforts physiques intenses et les sports de contact doivent être reportés d'environ **3–4 semaines**.
1er–3e mois	La muqueuse nasale cicatrise complètement. Le résultat respiratoire définitif est généralement évalué durant cette période.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Obstruction nasale et respiration par la bouche jusqu'au retrait des attelles
- Léger suintement teinté de sang les premiers jours
- Engourdissement temporaire des dents de devant du haut et de la lèvre supérieure
- Croûtes et sécheresse à l'intérieur du nez (les premières semaines)
- Diminution temporaire de l'odorat

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Croûtes et sécheresse prolongées** — Peuvent durer plusieurs semaines, en particulier si une réduction des cornets a été réalisée ; disparaissent avec les lavages et une pommade hydratante.
- **Engourdissement prolongé des dents du haut et de la lèvre** — Disparaît généralement en quelques semaines ; rarement, il peut durer quelques mois.
- **Obstruction ne disparaissant pas complètement** — Chez environ **15–30 patients sur 100**, la respiration peut ne pas s'améliorer autant que prévu. Cela est souvent dû à des facteurs supplémentaires tels qu'une allergie, un gonflement de la muqueuse ou une faiblesse des ailes du nez ; un traitement médicamenteux ou une chirurgie complémentaire peut être nécessaire.

Situations peu fréquentes

- **Saignement de nez (épistaxis)** — Chez environ **1–3 patients sur 100**, un saignement nécessitant un méchage peut survenir. Très rarement, il peut être nécessaire d'arrêter le saignement au bloc opératoire.
- **Trou dans la cloison (perforation septale)** — Chez environ **1–3 patients sur 100**, un trou peut se former dans la cloison. Il ne provoque souvent aucun symptôme ; s'il entraîne un sifflement, des croûtes ou des saignements, des lavages, la pose d'un bouton septal (obturateur) ou une opération de réparation peuvent être nécessaires.
- **Adhérences à l'intérieur du nez (synéchies)** — Chez environ **1–5 patients sur 100**, des adhérences peuvent se former entre la cloison et la paroi latérale ; si elles provoquent une obstruction, elles sont séparées par un geste simple lors d'une consultation de contrôle.
- **Collection de sang ou de pus dans la cloison (hématome / abcès de cloison)** — Survient chez **moins de 1 patient sur 100**. Elle se manifeste par une obstruction croissante, des douleurs et de la fièvre dans les jours suivant l'opération. La collection doit être **drainée en urgence** pour éviter d'endommager le cartilage du nez ; en l'absence de traitement, une perte de cartilage et un affaissement du dos du nez peuvent survenir.
- **Infection** — Rare ; elle guérit généralement sous antibiotiques.
- **Récidive de la déviation** — Le cartilage ayant une « mémoire », la cloison peut à nouveau se dévier légèrement avec le temps ; si cela entraîne des symptômes, une deuxième opération peut être nécessaire.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Affaissement du dos du nez (nez en selle)** — Survient chez **moins de 1 patient sur 100**. Un affaiblissement du cartilage de soutien de la cloison, ou une perte de cartilage après un hématome/abcès, peut entraîner l'affaissement du dos du nez ; cela modifie l'apparence extérieure du nez et nécessite, pour être corrigé, une opération supplémentaire avec greffe de cartilage.
- **Affaissement ou modification de forme de la pointe du nez** — Très rare ; peut survenir si les structures de soutien sont touchées.
- **Diminution ou perte définitive de l'odorat** — Très rare.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Fuite de liquide cérébrospinal (LCS) et méningite** — La partie supérieure de la cloison étant voisine de la base du crâne, il s'agit d'une complication extrêmement rare, survenant dans **bien moins de 1 cas sur 10 000**. Si elle survient, une hospitalisation, un traitement complémentaire et une opération de réparation peuvent être nécessaires.
- **Syndrome du nez vide** — Si les cornets sont trop réduits, une sensation d'obstruction et de sécheresse peut apparaître alors même que le nez est dégagé. Cette complication est très rare ; c'est pourquoi les cornets sont réduits de façon mesurée, en les préservant. Si elle apparaît, elle peut être durable ou définitive et elle est difficile à traiter.
- **Syndrome du choc toxique** — Maladie infectieuse très rare mais grave, liée à l'utilisation de mèches/attelles nasales (forte fièvre soudaine, éruption cutanée, chute de la tension artérielle), qui nécessite un traitement urgent. Elle impose une prise en charge hospitalière, parfois en réanimation, et peut mettre la vie en danger.
- **Troubles de la vision, saignement autour de l'œil** — Extrêmement rares avec une septoplastie ; le risque est un peu plus élevé en cas d'association à une chirurgie des sinus telle que la FESS, et il est expliqué sur un formulaire de consentement distinct.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Saignement de nez qui ne s'arrête pas ou très abondant** malgré quelques minutes de compression et l'application de glace, ou sang coulant en permanence dans la bouche
- **Obstruction nasale croissante, douleur intense et gonflement du nez** dans les jours suivant l'opération (peut être le signe d'un hématome/abcès de la cloison)
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C** ou écoulement malodorant
- **Forte fièvre soudaine, éruption cutanée, vertiges ou grande fatigue** alors que les mèches/attelles sont en place
- **Écoulement clair et aqueux** par le nez, en particulier s'il augmente lorsque vous vous penchez en avant ; maux de tête intenses ou raideur de la nuque
- **Vision trouble ou double**, ou gonflement autour de l'œil
- Essoufflement ou douleur thoracique

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Ne vous mouchez pas pendant les 2 premières semaines ; gardez la bouche ouverte lorsque vous éternuez.
- Rincez votre nez comme on vous l'a montré et aussi souvent que recommandé.
- Pendant les 2 premières semaines, évitez les bains chauds, le sauna, le hammam et le port de charges lourdes.
- Protégez votre nez des chocs pendant au moins 4 semaines.
- Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le voyage en avion est généralement sans danger une fois les attelles retirées.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

- ☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.
- ☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Je comprends que le but de cette opération est d'améliorer la respiration, et non de modifier l'apparence extérieure du nez, et qu'un traitement complémentaire peut être nécessaire si l'obstruction a d'autres causes.

☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**

☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.